

Sujet : 13 LE CANCER DU COL DE L'UTERUS

QCM 1

Concernant l'artère utérine, quelles affirmations sont vraies ?

- a. Elle naît de l'artère iliaque externe.
- b. Elle naît du tronc ventral de l'artère iliaque interne
- c. Elle se termine au niveau de la corne utérine.
- d. Elle donne des branches cervico-vaginales.
- e. C'est l'artère principale de l'utérus

QCM 2

Le drainage lymphatique de l'utérus concerne principalement :

- a. Les ganglions inguinaux.
- b. Les ganglions obturateurs.
- c. Les ganglions interiliaques.
- d. Les ganglions iliaques externes
- e. Les ganglions lomboaortiques.

QCM 3

Concernant le HPV :

- a. Les génotypes 6 et 11 sont responsables de 70 % des cancers du col.
- b. L'infection est toujours persistante.
- c. Le HPV 16 et 18 sont ciblés par la vaccination.
- d. Le virus pénètre les cellules basales à travers un microtraumatisme tissulaire.
- e. Le pic de prévalence de l'infection HPV se situe entre 40 et 50 ans.

QCM 4

Concernant l'Humain Papillome virus (HPV)

- a. L'agent pathogène incriminé dans la genèse du cancer du col utérin est le papillomavirus humain (HPV)
- b. Le HPV peuvent infecter la sphère anale et /ou génitale
- c. Les HPV types 6, 11 sont impliqués dans la genèse des lésions intra-épithéliales de bas grade
- d. Il existe 6 génotypes HPV à fort potentiel oncogène pour le col utérin
- e. Les HPV types 16 et 18 sont responsables de 50% des cancers du col utérin

QCM 5

Concernant les lésions précancéreuses du col :

- a. Elles sont visibles à l'œil nu.
- b. Elles respectent la membrane basale.
- c. Leur classification actuelle parle de LSIL et HSIL.
- d. Le carcinome in situ infiltre le chorion.
- e. Le CIN1 correspond à une dysplasie sévère.

QCM 6

Concernant la genèse du cancer du col utérin :

- a. Le cancer du col utérin est une maladie sexuellement transmise
- b. La prévalence de l'infection par le HPV est élevée après 30 ans
- c. L'infection à HPV est souvent transitoire et le virus est éliminé en quelques années
- d. Les lésions précancéreuses du col utérin sont favorisées par la persistance des HPV à haut risque
- e. L'intégration de l'ARN viral au génome de la cellule hôte est la première étape de la cancérogenèse cervicale

QCM 7

Parmi les formes macroscopiques du cancer invasif du col, on trouve :

- a. Forme végétante exophytique.
- b. Forme infiltrante.
- c. Forme ulcérée.
- d. Forme papillaire.
- e. Forme ulcéro-bourgeonnante.

QCM 8

Les propositions exactes concernant la cancérogenèse du col utérin :

- a. Le cancer du col est toujours précédé par des lésions précancéreuses
- b. Le cancer du col utérin débute au niveau de zone de jonction entre l'endocol et l'exocol
- c. La membrane basale est toujours respectée.
- d. La progression des lésions est lente
- e. Les lésions de bas grade du col utérin peuvent régresser spontanément

QCM 9

Le cancer du col in situ :

- a. Est classé comme un CIN3 selon la classification de Richard 1973
- b. Le carcinome in situ n'est pas vu à l'œil nu
- c. Ne dépasse pas la membrane basale
- d. Peut se manifester par des métrorragies post coïtales
- e. Est confirmé par une conisation avec limites saines

QCM 10

Concernant le carcinome invasif du col utérin :

- a. Le carcinome épidermoïde représente plus de 80% des cancers du col.
- b. L'adénocarcinome se développe au dépens de la muqueuse exo cervicale
- c. L'extension se fait de proche en proche vers le vagin, les paramètres, les organes pelviens de voisinage
- d. L'envahissement lymphatique est fréquent en cas de cancer de col utérin.
- e. Plus la tumeur est augmentée de taille plus le risque d'atteinte ganglionnaire est augmenté

QCM 11

Le carcinome épidermoïde du col utérin :

- a. A une évolution locorégionale
- b. Donne des métastases à distance
- c. Est un cancer lymphophile
- d. Les métastases ganglionnaires lymphatiques pelviennes sont fréquentes
- e. La chirurgie est le traitement de référence dans les stades avancés

QCM 12

L'infection à HPV:

- a. Est toujours oncogène
- b. Peut être associée à un condylome
- c. Moins de 5 % des femmes infectées par HPV 16 développe un cancer du col utérin
- d. Nécessite un cofacteur pour développer un carcinome in situ
- e. En cas de coinfection HPV et HIV, le développement de lésions précancéreuses et cancéreuses est plus rapide et leur fréquence plus élevée.

QCM 13

Facteurs de risque du cancer du col de l'utérus :

- a. Début tardif de l'activité sexuelle.
- b. Nombre élevé de partenaires sexuels.
- c. Tabagisme.
- d. Infection par le VIH.
- e. Utilisation du stérilet.

QCM 14

La dysplasie cervicale

- a. Est un état précancéreux
- b. Est un carcinome micro invasif
- c. Est classée en plusieurs grades
- d. Toujours réversible sous traitement
- e. Peut donner des métastases

QCM 15

Le carcinome épidermoïde microinvasif du col

- a. Est diagnostiqué lors de l'examen clinique
- b. Il s'agit d'une lésion précancéreuse
- c. Est équivalent de CIN3
- d. Présente un faible potentiel métastatique
- e. Est caractérisé par une invasion de moins 5mm de profondeur et moins de 7 mm en surface

QCM 16

Madame A, âgée de 36 ans, antécédents de 2 FCV normaux, a fait un test HPV revenu positif. Quelle est la conduite à tenir ?

- a. Examen cytologique
- b. Colposcopie
- c. Biopsie du col
- d. Conisation
- e. Refaire le test HPV dans 1 an

QCM 17

Concernant le frottis cervical, quelles sont les réponses exactes ?

- a. Il s'agit d'un dépistage des lésions précancéreuses
- b. Est indiqué obligatoirement devant un test HPV positif
- c. Il est indiqué chez la femme vierge
- d. Est réalisé d'emblée tous les 3 ans
- e. Il s'agit d'un examen histologique

QCM 18

Quels sont les modes d'extension du cancer du col ?

- a. Extension locorégionale aux organes pelviens.
- b. Propagation hémotogène fréquente vers le cerveau.
- c. Extension lymphatique vers les ganglions pelviens.
- d. Les métastases à distances sont fréquents et précoces
- e. Métastases pulmonaires possibles dans les stades avancés.

QCM 19

Les signes cliniques évocateurs du cancer du col sont :

- a. Métrorragies post-coïtales.
- b. Leucorrhées purulentes malodorantes.
- c. Ménorragies isolées.
- d. Douleurs pelviennes tardives.
- e. Spanioménorrhées.

QCM 20

Le diagnostic positif du cancer du col repose sur :

- a. Le frottis cervico-utérin.
- b. La biopsie cervicale.
- c. L'IRM pelvienne.
- d. L'histologie d'une conisation.
- e. La cytologie seule suffit.

QCM 21

Facteurs pronostiques du cancer du col utérin :

- a. Stade FIGO.
- b. Taille tumorale.
- c. Âge de la patiente.
- d. Présence d'emboles lymphatiques.
- e. Siègne de la tumeur sur le col

QCM 22

L'IRM pelvienne est utile pour :

- a. Évaluer la taille tumorale.
- b. Rechercher des métastases cérébrales.
- c. Apprécier l'extension aux paramètres.
- d. La détection de la récurrence tumorale post-thérapeutique.
- e. Opacifier les vaisseaux lymphatiques.

QCM 23

La conisation est indiquée pour :

- a. Une lésion du col visible macroscopiquement.
- b. Une HSIL avec colposcopie non satisfaisante.
- c. Un adénocarcinome in situ diagnostiqué à la biopsie du col.
- d. Une patiente avec cancer infiltrant stade IB3.
- e. Une patiente enceinte avec existence d'une tumeur bourgeonnante du col

QCM 24

Concernant la radiothérapie externe :

- a. Elle est utilisée dans tous les stades.
- b. Elle cible le vagin, les paramètres et ganglions pelviens.
- c. La dose totale est de 20 Gy.
- d. Elle est associée à la curiethérapie.
- e. Elle peut entraîner une rectite radique.

QCM 25

Les complications tardives de la radiothérapie sont :

- a. Sigmoidite.
- b. Sténose urétérale.
- c. Dyspareunie.
- d. Cystite hémorragique.
- e. Fistule recto-vaginale.

QCM 26

Concernant la chimiothérapie dans le cancer du col :

- a. Elle est utilisée dans les carcinomes in situ
- b. Elle est surtout utilisée en association à la radiothérapie.
- c. Elle utilise souvent les sels de platine.
- d. Elle est contre-indiquée chez les femmes jeunes.
- e. Elle peut entraîner une aplasie fébrile.

QCM 27

Le traitement du stade IB3 - IVA est :

- a. Chirurgie radicale.
- b. Radiochimiothérapie concomitante.
- c. Conisation simple.
- d. Curithérapie seule.
- e. Une lymphadenectomie lomboaortique première pour rechercher une atteinte ganglionnaire peut être indiquée

QCM 28

La surveillance post-thérapeutique comprend :

- a. Examen clinique régulier.
- b. Une IRM annuelle pendant les 5 premières années en cas de traitement conservateur
- c. Frottis systématique après radiothérapie.
- d. Dosage SCC si positif initialement.
- e. Biopsie vaginale mensuelle.

QCM 29

La vaccination anti-HPV :

- a. Cible les garçons et les filles
- b. Utilise un vaccin nonavalent.
- c. Protège contre tous les HPV oncogènes.
- d. Est recommandée dès 11 ans.
- e. Évite le recours au frottis.

QCM 30

Le dépistage organisé du cancer du col :

- a. Commence à 25 ans.
- b. Se fait uniquement chez les femmes à risque.
- c. Utilise le test HPV dès 30 ans.
- d. Est inutile après 45 ans.
- e. Doit être associé obligatoirement à la vaccination.

QCM 31

Le frottis cervico-utérin (FCU) :

- a. Est réalisé pendant les règles.
- b. Utilise une spatule d'Ayre et une cytobrosse.
- c. Est interprété selon la classification de Bethesda.
- d. Peut montrer des ASC-US.
- e. Doit être répété tous les mois.

CAS CLINIQUE 1

Mme B., 52 ans, consulte avec les résultats d'une colposcopie-biopsie cervicale concluant à un carcinome in situ du col utérin

QCM 1.1 – Les facteurs de risque du cancer du col incluent :

- a. L'infection persistante à HPV
- b. Le tabagisme
- c. L'immunodépression
- d. La nulliparité
- e. Le début tardif de l'activité sexuelle

QCM 1.2 – Concernant l’HPV :

- a. L’HPV 16,18 sont les plus oncogènes
- b. L’HPV 6 est responsable de cancers invasifs
- c. L’HPV est toujours symptomatique
- d. L’HPV peut être éliminé spontanément
- e. L’infection par HPV à haut risque est transitoire dans tous les cas

QCM 1.3 – Le risque de cancer est majoré chez :

- a. Les femmes utilisant un DIU
- b. Les femmes VIH positives
- c. Les femmes avec nombreux partenaires
- d. Les femmes ménopausées
- e. Les femmes vaccinées contre HPV

QCM 1.4 – Concernant l’anatomie pathologique du cancer du col de l’utérus :

- a. Le carcinome épidermoïde est le plus fréquent
- b. Le carcinome in situ infiltre les structures voisines
- c. Le cancer micro-invasif se définit par une infiltration stromale des cellules néoplasiques au-delà de la membrane basale, limitée à une profondeur inférieure ou égale à 5 mm
- d. L’adénocarcinome du col naît de l’épithélium endocervical
- e. Le sarcome est une forme rare

QCM 1.5 – Le carcinome in situ :

- a. Respecte la membrane basale
- b. Est visible à l’œil nu
- c. Donne souvent des métastases
- d. Est toujours associé à des douleurs
- e. le diagnostic de certitude se fait sur une pièce de conisation

CAS CLINIQUE 2

Mme C., 50 ans, découvre une lésion cervicale suspecte à l’examen systématique. Biopsie positive pour carcinome épidermoïde stade IB1.

QCM 2.1 – Il s’agit de

- a. un Cancer limité au col
- b. Taille de la tumeur < 2cm
- c. Existence de métastase ganglionnaire
- d. Tumeur avec infiltration des paramètres
- e. Tumeur avec probable envahissement urétéral

QCM 2.2 – En IRM pelvienne, on peut évaluer :

- a. Le volume tumoral
- b. L'extension paramétriale
- c. L'atteinte ganglionnaire
- d. L'invasion rectale
- e. l'existence ou non de métastases hépatiques

QCM 3.3 – Le traitement de référence au stade IB1 comprend :

- a. Une colpohystérectomie élargie, une ovariectomie bilatérale et une lymphadenectomie pelvienne
- b. Intervention de Wertheim
- c. Chimiothérapie exclusive
- d. Curiethérapie première suivie d'une colpohystérectomie élargie
- e. Hystérectomie simple

QCM 3.4 – La lymphadénectomie pelvienne permet :

- a. D'évaluer le statut ganglionnaire
- b. D'améliorer la fertilité
- c. De guérir le cancer
- d. D'éviter la radiothérapie
- e. D'éviter la chimiothérapie

QCM 3.5. La prise en charge post thérapeutique de cette patiente

- a. Le suivi sera fait sur cinq ans
- b. Une enquête familiale est faite à la recherche de cas similaire
- c. Se base sur l'examen physique seulement si pas de signes d'appel clinique
- d. Se base sur le dosage des marqueurs tumoraux ca 125
- e. Se base sur le frottis cervico utérin et le test HPV

Cas clinique 3

Mme F., 30 ans, consulte pour bilan de fertilité. Elle n'a jamais réalisé de frottis cervico-utérin. Aucun antécédent notable. Vous décidez de réaliser un test de dépistage du cancer du col chez cette femme.

QCM 3.1 – Votre conduite à tenir chez cette femme:

- a. Réaliser un FCV
- b. Le dépistage n'est pas indiqué chez cette femme
- c. Le dépistage du cancer du col inutile si elle est vaccinées
- d. Un FCV doit être fait tous les 5 ans
- e. Le dépistage du cancer du col repose sur un test HPV d'emblée parce que elle est âgée de 30 ans

QCM 3.2 – Le test HPV :

- a. Repose sur la détection de l'ADN viral
- b. A une meilleure sensibilité que le FCU
- c. Est recommandé en première intention avant 25 ans
- d. Est moins spécifique que le FCU
- e. Ne peut pas être utilisé chez les femmes immunodéprimées

QCM 3.3 – Le vaccin anti-HPV :

- a. Est indiqué avant les premiers rapports sexuels
- b. Couvre les génotypes 16 et 18 pour le Cervarix
- c. Est inutile après 18 ans
- d. Protège contre tous les types de HPV
- e. Est contre-indiqué chez les garçons

QCM 3.4 – En prévention secondaire, un FCU :

- a. Doit être réalisé avec une cytobrosse pour l'exocol
- b. Est un examen histologique
- c. Doit être réalisé à distance des règles
- d. la vaccination par le Cervarix dispense du dépistage par le FCV
- e. Peut être remplacé par l'IRM pelvienne

QCM 3.5 – Chez une patiente de 30 à 65 ans avec antécédents de deux frottis normaux :

- a. Un test HPV tous les 5 ans est recommandé
- b. Le FCU est suffisant tous les 2 ans
- c. Le dépistage est inutile en l'absence de facteur de risque
- d. Le frottis est abandonné au profit de l'autoprélèvement
- e. Un test HPV est inutile si la patiente est vaccinée

Cas clinique n°4 :

Mme F.H ; 40 ans ; mère de 5 enfants, le premier âgée de 22 ans ayant des antécédents personnels de cancer du sein et familiaux de cancers du colon et de l'endomètre, consulte pour des métrorragies post coïtales.

QCM 4.1 Quels sont les facteurs de risque du cancer du col chez cette patiente ?

- a. 1ère grossesse précoce
- b. La multiparité
- c. L'antécédent personnel de cancer du sein
- d. Les antécédents familiaux d'adénocarcinomes
- e. Aucun

L'examen physique trouve une lésion bourgeonnante et hémorragique du col utérin de 4 cm de diamètre, le vagin paraît indemne de toute lésion.

QCM 4.2. Quelle est votre conduite à tenir dans un premier temps?

- A. Un frottis cervico-utérin
- B. Une colposcopie avec des biopsies dirigées
- C. Une biopsie de la lésion objectivée à l'examen physique
- D. une cœlioscopie diagnostique
- E. une TDM pelvienne

L'examen anatomo-pathologique confirme le diagnostic d'un carcinome épidermoïde invasif.

QCM 4.3 Le bilan d'extension comporte :

- a. un dosage de l'antigène carcino embryonnaire
- b. une IRM pelvienne
- c. une hystéroscopie
- d. une TDM pelvienne
- e. une coelioscopie

L'examen général est sans anomalie et le bilan d'extension confirme la présence d'une masse cervicale de 4 cm ; avec paramètres, vagin, isthme utérin, cloison vésico-utérine, paroi rectale et paroi pelvienne libres.

QCM 4.4. Comment classer cette lésion selon la classification FIGO 2018 ?

- a. IA1
- b. IB1
- c. IB3
- d. IIA1
- e. IIIA

QCM 4.5. Quel est le traitement de référence que vous proposez à cette patiente ?

- a. Une conisation
- b. Une trachélectomie
- c. Une hystérectomie élargie
- d. Une radio-chimiothérapie concomitante
- e. Une radiothérapie seule

Cas clinique 5

Madame Moufida, âgée de 49 ans consulte pour des métrorragies associées à des douleurs pelviennes. Elle a comme antécédents cinq accouchements par voie basse. Sa grand-mère maternelle est décédée d'un cancer colorectal à l'âge de 46 ans et sa tante maternelle a été opérée cette année d'un stérilet au cuivre depuis neuf ans.

QCM 5.1. Parmi les facteurs de risque du cancer du col de l'utérus vous retenez :

- a. Le tabac.
- b. La contraception par stérilet .
- c. La ménopause précoce.
- d. La multiparité.
- e. Les ATCD familiaux de cancer

QCM 5.2. L'examen montre une lésion bourgeonnante du col du col. Que faire ?

- a. Frottis cervico-utérin.
- b. Colposcopie.
- c. Biopsie du col.
- d. IRM pelvienne.
- e. Radiographie du thorax.

QCM 5.3. Après les explorations, la patiente présente un cancer du col au stade IIB. Quelle est la proposition exacte :

- a. Cancer du col utérin avec envahissement des paramètres
- b. Adénocarcinome du col utérin avec envahissement de la vessie
- c. Un cancer micro-invasif
- d. Un cancer du col avec envahissement du 1/3 inférieur du vagin
- e. Un cancer visible limité au col inférieur à deux centimètre

QCM 5.4. Quelle est votre attitude thérapeutique ?

- a. Une Conisation
- b. Une Trachélectomie
- c. Une vaporisation laser
- d. Intervention de type « Wertheim »
- e. Une radio-chimiothérapie concomitante